UHS | UNIVERSITY HOSPITAL SHARJAH
مستشفى الجامعة بالشارقة

JCI ACCREDITED
SINCE 2015

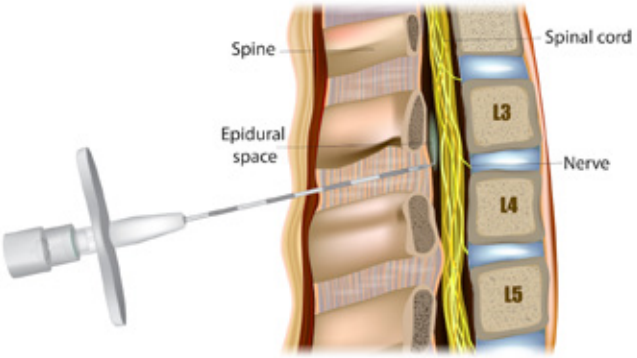
Epidural Your Choice

University Hospital Sharjah

UNIVERSITY HOSPITAL SHARJAH
P.O. Box 72772, University City, Sharjah, UAE, Tel: +971 6 5058555, Fax: +971 6 5058444
@UHSharjah | www.uhs.ae

What Is Epidural Analgesia?

An epidural is an anaesthetic delivered through a catheter (small tube) into a potential space outside the spinal cord called the epidural space. Using this catheter, we are able to infuse a solution that usually includes a local anaesthetic and opioids.



About 30 - 35 in every 100 women, who give birth at the University Hospital of Sharjah, choose to have an epidural.

Can anyone have an epidural?

Almost every woman can have an epidural. However, there are certain medical conditions or medications that can make an epidural difficult or risky to insert. This would require a discussion with an anaesthetist. There are other pain relief options when you are in labour, and you can request an epidural at any time.
We will endeavour to site an epidural as soon as possible. However, on some occasions there may be a delay if an anaesthetist is busy with other patients.

What are the benefits of an epidural?

- The only appropriate and reliable way used to ease the labour pain.
- Ensures adequate blood flow to the placenta during the contractions, means they do not directly affect the baby.
- Our Patient Controlled Epidural Analgesia (PCEA) machine provides automated intermittent boluses, along with a button that the patient can press as needed. This system offers effective pain relief while helping to maintain your energy and pushing strength during labour.
- You do not have a higher chance of needing a caesarean section or prolongation of your normal delivery
- If the epidural is working well, usually means that it will be used during a caesarean and you will be awake for the birth of your baby.

What are the problems with epidurals?

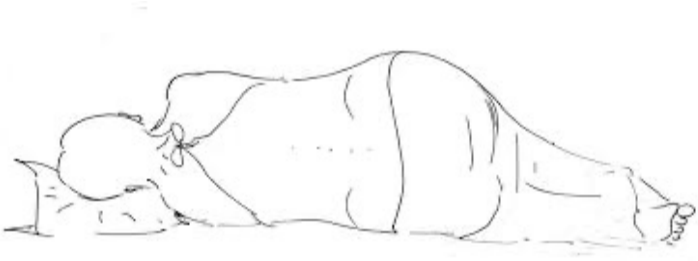
- Your blood pressure may drop, causing you to feel light-headed or nauseous. We will check your blood pressure often while you have an epidural in place.
- You will need to stay in bed because your legs may feel heavy and numb.
- The epidural may take away the feeling or urge to urinate. We will use a catheter, which is a tube that collects urine from your bladder.
- You may feel shivery, feverish or itchy.
- The epidural may not always provide total pain relief. If you still have pain, the anaesthetist may use more anaesthetic. Sometimes though, the epidural will need to be replaced.
- In case of a severe headache in the days following the epidural, this can be treated.

What are the risks of an epidural and occurrence rate?

TYPE OF RISKS	INCIDENCE
Site of injection pain (mild Back pain)	20-30%
Neck pain	10-20%
Shoulder pain	5-10 %
Not working well enough to reduce labor pain & additional pain relief measures needed on top of epidural	10-15%
Epidural not functioning well enough for caesarean delivery, require general anesthesia	5%
Potential re-site of the epidural catheter	5%
Significant drop in Blood pressure	2%
Mild Headache	10 -15%
Severe headache	1 %
Unintentional Dural puncture	1-6 %
Post-Dural puncture headache	75-85%
Temporary nerve damage (patch of numbness or weakness in the leg)	1/1000
Permanent nerve damage (more than 6 months)	1/13000
Epidural abscess (infection)	1/50000
Meningitis	1/100000
Epidural hematoma (blood clot)	1/170000
Severe injury (including paralysis)	1/250000

How is an epidural given?

- An anaesthetist will put the epidural in, this takes about 20 minutes. He will ask about your general health, current pregnancy and if you are on any medication. Then they will describe the procedure, discuss risks and benefits, and obtain consent.
- A drip will be put in your hand or arm.
- Vital signs will be taken (blood pressure, Heart rate and temperature).
- We will help into position to place the epidural, either sitting up bending forwards to curve your back or lying on your side.

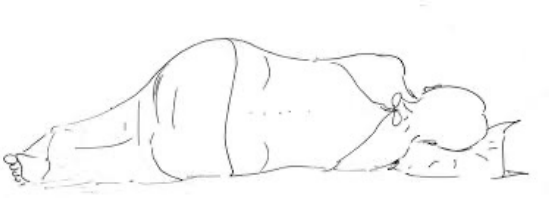


- Your back will be cleaned with an antiseptic solution.
- Local anaesthetic is injected into the skin in the middle of your lower back to numb the skin. This briefly stings.
- You should only feel pressure where the epidural needle is inserted. It is important that you keep perfectly still while this is done to avoid any damage to the nerves in your spine.
- When the needle is in the correct position, a thin plastic tube (catheter) is inserted.
- You may feel an electric shock in your back and down your legs. This will last for a moment and then go away. It is not harmful.
- The needle is then removed. The catheter stays in place and is secured with tape.
- Local anaesthetic is given down the tube, blocking pain from the nerves of the spine. It takes about 15- 20 minutes to take effect.
- The dose can be adjusted so that you can still feel your contractions, but they will not be painful, and you will be able to push when the time comes.
- It is very common and normal for an epidural to not completely cover the pressure pain during the second stage of labour (pushing)
- If the epidural is patchy, one sided or not relieving pain then it may need to be withdrawn little or to be replaced.
- Once your baby is delivered and the plastic tube is removed it can take up to 4-6 hours for all sensations to return to normal.

For more information or advice, you will be able to ask questions and voice your concerns to your obstetrician, anaesthetist, midwife, or nurse.

كيف تُعطى الإبرة فوق الجافية؟

- سيقوم طبيب التخدير بإعطاء الإبرة فوق الجافية، ويستغرق ذلك حوالي ٢٠ دقيقة. سيطرح عليكِ أسئلة عن صحتك العامة، وحملك الحالي، وإذا كنتِ تتناولين أي أدوية. بعد ذلك، سيشرح لكِ الإجراء، ويعرض المخاطر والفوائد، ويأخذ موافقتك.
- سيتم وضع حقنة في يدك أو ذراعك.
- سيتم قياس العلامات الحيوية (ضغط الدم، معدل ضربات القلب، والحرارة).
- سنساعدكِ على إتخاذ الوضعية المناسبة لوضع الإبرة فوق الجافية، إما بالجلوس مع الإنحناء للأمام لتقويس ظَهرك أو الإستلقاء على جانبك.



- سيتم تنظيف ظهرك بإستخدام محلول مطهر.
- يتم حقن مخدر موضعي في الجلد في منتصف أسفل ظهرك لتخدير الجلد. قد تشعرين بوخز لفترة قصيرة.
- يجب أن تشعري بالضغط فقط في المكان الذي يتم فيه إدخال الإبرة فوق الجافية. من المهم أن تظلّي ثابتة تمامًا أثناء القيام بذلك لتجنب أي ضرر للأعصاب في عمودك الفقري.
- عندما تكون الإبرة في الموضع الصحيح، يتم إدخال أنبوب بلاستيكي رفيع (قسطرة).
- قد تشعرين بإحساس كهربائي في ظهرك وأسفل ساقيك، وسيستمر لبضع لحظات قبل أن يختفي. لا داعي للقلق، فهذا ليس ضارًا.
- ثم يتم إزالة الإبرة. تبقى القسطرة في مكانها ويتم تأمينها بالشريط اللاصق.
- يتم إعطاء مخدر موضعي عبر القسطرة، مما يمنع الألم من الأعصاب في العمود الفقري. يستغرق هذا حوالي ٢٠ دقيقة ليأخذ مفعوله.
- يمكن تعديل الجرعة بحيث لا يزال بإمكانكِ الشعور بتقلصاتك، لكنها لن تكون مؤلمة، وستتمكنين من الدفع عندما يحين الوقت.
- من الشائع والطبيعي أن لا يغطي التخدير فوق الجافية تمامًا ألم الضغط خلال المرحلة الثانية من المخاض (الدفع).
- إذا كانت الإبرة فوق الجافية غير فعالة أو أحادية الجانب أو لا تخفف الألم بشكل كافٍ، فقد تحتاج إلى إستبدال.
- بعد ولادة طفلك وإزالة الأنبوب البلاستيكي، قد يستغرق الأمر من ٤ إلى ٦ ساعات حتى تعود جميع الأحاسيس إلى طبيعتها.

للمزيد من المعلومات أو النصائح، يمكنكِ طرح الأسئلة ومناقشة مخاوفك مع طبيب التوليد، أو طبيب التخدير، أو القابلة، أو الممرضة.

ما هي المشاكل المتعلقة بالإبرة فوق الجافية؟

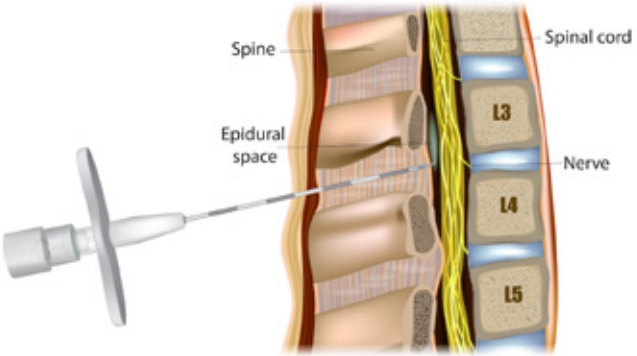
- قد ينخفض ضغط دمك، ممَا قد يجعلك تشعرين بالدوار أو الغثيان. سنتحقق من ضغط دمك بشكل منتظم أثناء إستخدام الإبرة فوق الجافية.
- ستحتاجين للبقاء في السرير لإحتمال الشعور بالثقل أو التنميل في ساقيك.
- قد تجعل الإبرة فوق الجافية شعورك أو حاجتك للتبول تختفي. سنستخدم قسطرة لجمع البول من مثانتك.
- قد تشعرين بالقشعريرة أو بالحمى أو بالحكة.
- قد لا توفر الإبرة فوق الجافية تخفيفًا كاملاً للألم بشكل دائم. إذا كنتِ لا زلتِ تشعرين بالألم، قد يستخدم طبيب التخدير المزيد من المخدر. في بعض الأحيان، قد تحتاج الإبرة فوق الجافية إلى إستبدال.
- في حال الإصابة بصداع شديد في الأيام التي تلي الإبرة فوق الجافية، يمكن علاج ذلك.

ما هي المخاطر المحتملة للإبرة فوق الجافية؟ وما معدل حدوثها؟

الأخطار المحتملة	معدل الحدوث
ألم فى موضع الحقن (ألم خفيف أسفل الظهر)	20-30%
ألم خلف الرقبة	10-20%
ألم فى مفصل الكتف	5-10 %
الحقنة لا تعمل بشكل جيد بما يكفى لتقليل الام المخاض . . ما قد يستلزم اتخاذ إجراءات إضافية	10-15%
الحقنة لا تعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية لعملية قيصرية ما قد يتطلب تخدير عام	5%
إحتمال إعادة تركيب القسطرة حول الجافية	5%
إنخفاض ملحوظ فى ضغط الدم	2%
صداع خفيف	10 -15%
صداع شديد	1 %
ثقب الجافية الغير مقصود	1-6 %
صداع ما بعد ثقب الجافية	75-85%
تلف مؤقت فى أعصاب الساقين (تنميل أو ضعف فى الساق أو القدم)	1/1000
تلف دائم فى الأعصاب (أكثر من ٦ شهور)	1/13000
خراج حول الجافية (عدوى)	1/50000
إلتهاب سحائي	1/100000
تجمع دموى حول الجافية	1/170000
إصابة شديدة بالأعصاب قد تصل إلى الشلل	1/250000

ما هو التخدير فوق الجافية؟

التخدير فوق الجافية هو مخدر يُعطى من خلال قسطرة (أنبوب صغير) إلى مساحة محتملة خارج الحبل الشوكي تسمى الفضاء فوق الجافية. بإستخدام هذه القسطرة، يمكننا ضخ محلول عادة ما يتضمن مخدر موضعي ومُسكنات أفيونية.



حوالي ٣٠ إلى ٣٥ من كل ١٠٠ امرأة تلد في مستشفى الجامعة بالشارقة ، يخترن إستخدام الإبرة فوق الجافية.

هل يمكن للجميع إستخدام الإبرة فوق الجافية؟

يمكن تقريباً لكل امرأة أن تستخدم الإبرة فوق الجافية. ومع ذلك، هناك بعض الحالات الطبية أو الأدوية التي قد تجعل من الصعب إدخال الإبرة فوق الجافية. في هذه الحالة، يتطلب الأمر مناقشة مع طبيب التخدير. هناك خيارات أخرى لتخفيف الألم أثناء المخاض، ويمكنك طلب الإبرة فوق الجافية في أي وقت.

سنحرص على وضع الإبرة فوق الجافية في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك، في بعض الأحيان قد يكون هناك تأخير إذا كان طبيب التخدير مشغولاً مع مرضى آخرين.

ما هي فوائد التخدير فوق الجافية؟

- الطريقة الوحيدة المناسبة والموثوقة المستخدمة لتخفيف ألم المخاض.
- يضمن تدفق دم كافٍ للمشيمة خلال الإنقباضات، مما يعني أنها لا تؤثر مباشرة على الطفل.
- جهاز التخدير فوق الجافية المُتحكم فيه من قبل المريض (PCEA) يوفر جرعات متقطعة تلقائية، بالإضافة إلى زر يمكنك الضغط عليه عند الحاجة. يتيح هذا النظام تخفيف الألم بشكل فعال مع المساعدة في الحفاظ على طاقتك وقوة الدفع أثناء الولادة.
- ليس لديك فرصة أكبر لإحتياجك لعملية قيصرية أو تمديد وقت الولادة الطبيعية.
- إذا كان التخدير فوق الجافية يعمل بشكل جيد، فهذا يعني عادةً أنه سيتم إستخدامه أثناء عملية قيصرية وستكونين مستيقظة أثناء ولادة طفلك.

UHS | UNIVERSITY HOSPITAL SHARJAH
مستشفى الجامعة بالشارقة

JCI ACCREDITED
SINCE 2015

إبرة فوق الجافية - خيارك

مستشفى الجامعة بالشارقة

UNIVERSITY HOSPITAL SHARJAH
P.O. Box 72772, University City, Sharjah, UAE, Tel: +971 6 5058555, Fax: +971 6 5058444
@UHSharjah | www.uhs.ae